



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رابعياً : مكاسب بدرى حامد -

العنوان : حلوان

الحي / المدينة : حلوان

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

رقم البطاقة : 25701060104746 رقم التليفون : 01121874533

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-01-1957 المهنة : لاتعمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ بالصبغة [12771] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----

التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مكاسب بدرى حامد - National ID: 25701060104746	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced MRI of the brain.
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٥/٠٨ ٢٥٧٠١٠٦٠١٠٤٧٤٦
 بون عمل
 إتش
 محمد حسن علي خيت
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٨/٢٧
 مخرجة

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 مكاتب
 بيري حامد
 ٢٢ عزبة زين-ش النسخة
 حوان - القاهرة
 ٢٥٧٠١٠٦٠١٠٤٧٤٦
 L15765985

DM S
 ملحوظة
 ٢٥٧٠١٠٦٠١٠٤٧٤٦

سواله
 *
 *
 *
 *
 *
 *



Women's Health Outreach Program

Name : Makaseb Sayed Hamed

Date: 25/05/2022

Bilateral Full field Digital Mammography With High Resolution Ultrasonography

Clinical summary: 70 years old female with palpable right breast mass of one month duration.

Technique

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Homogenous fatty breast parenchyma (ACR a)
- LOQ high density irregular mass lesion with angulated margins.
- No suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated a LOQ hypoechoic irregular solid mass showing angulated margins ; measuring 48 x 34 mm , seen at 7-8 o'clock , 3 mm from the skin and about 5 cm from the nipple. it showed moderate internal vascularity on colour Doppler study.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Pathological multiple enlarged axillary LNs (level 1&2); the largest measured 28 x 25 mm.

Left breast

- Homogenous fatty breast parenchyma (ACR a)
- No masses, asymmetric densities , distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs .

Impression :

Right breast (BURADS 5): LIQ malignant looking solid mass lesion with ipsilateral pathological (level1 &2) axillary lymph nodes.

Left Breast (BIRADs 1) : Normal study.

Recommendation

Right breast : biopsy and histopathological correlation.

Left breast: annual screening.

Best regards,
Dr/Amal Hegazi, M.Sc

Name : Makaseb Mahmoud

DATE : 18/8/2022

C.T. Scan examination of chest without contrast injection revealed:

- Right lower lobe single patch is seen affecting right lung .
- No evidence of mediastinal or hilar lymph node enlargement, masses or calcifications is seen.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses is seen.
- Average cardiac size .

Conclusion:

Considering the global pandemic crisis , the described finding is low suspicious of COVID-19 pneumonia , CORADS 3 for clinical & lab correlation .

Kindly Accept My Best Wishes,
Dr.Shaimaa Samir

Women's Health Outreach Program

Name: Makaseb Badery hamaed

Date: 18-7-2022

Right breast clip localization

Clinical summary: Clip insertion for right breast LOQ pathologically proven malignant lesion

Target U/S was done for right breast LOQ malignant solid lesions with clip insertion at center of lesion and it was confirmed by CC and MLO views

Dr. Marwa M.Hassan

AP. 111111. 111111



لجنة صحة المرأة السعودية



MDT FORM

814/2023 GB

Name	سكينة بن عبد الله	MRN	542
Age		ID	500.1.7.1.8.1.8.1
Menopausal status		Phone	011 51111111
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Post op

Clinical Data

BX: Rt IDC GII

ER: 8/8 PR: 8/8 HER 2: -ve Ki67: 50%

Sonomammography: Rt breast Ca cTub N1 Mo

Mets Workup: ended NAC AC x4 Taxol x12 weeks

R

L



Rt. SM + SLNBx → 27-2-2023
TNM

Recommendations:

IDC GII YPT3, YPN0, poor pathologic response.
DCIS
Free nipple, skin & SLNBx (0/9)
Free margins.

MDT OUTCOME & PLAN

8/4/2023 → - PORT
- A.I / DEXA scan.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. الزمان		د. الزمان			